

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

EDI-2 · INVENTARIO DE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

Eating Disorder Inventory-2 – Evaluación multidimensional de rasgos psicológicos y conductuales en TCA

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial	Eating Disorder Inventory - 2 (EDI-2)
Autores Originales	David M. Garner (1991); versión inicial EDI por Garner, Olmsted y Polivy (1983)
Adaptación Española	Guimerá y Torrubia (1987); TEA Ediciones (Garner, 1998)
Tipo de Instrumento	Autoinforme psicométrico multidimensional
Población Diana	Adolescentes y adultos a partir de 11 años con sospecha o diagnóstico de TCA
Tiempo de Aplicación	15 a 25 minutos (91 ítems EDI-2 o 64 ítems nucleares EDI)
Formato de Respuesta	Escala tipo Likert de 6 puntos (Nunca a Siempre; puntuación clínica 0-3)
Finalidad Clínica	Perfilado psicopatológico dimensional, diseño de intervención cognitivo-conductual y monitorización de evolución clínica en TCA

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

El EDI fue concebido para superar las limitaciones de los instrumentos puramente conductuales de cribado (como el EAT), los cuales detectan anomalías en la dieta pero no exploran los constructos psicológicos subyacentes que originan y mantienen los trastornos de la conducta alimentaria. David M. Garner estructuró el EDI como una batería factorial que integra actitudes y comportamientos alimentarios específicos junto a rasgos psicológicos nucleares de vulnerabilidad de la personalidad.

El modelo teórico distingue dos grandes ejes: a) **Escalas específicas de TCA**, que capturan el impulso por la delgadez (dieta estricta y pánico a engordar), la bulimia (atracones y purgas) y la insatisfacción corporal (rechazo de silueta); y b) **Escalas psicológicas generales**, que exploran la ineficacia, perfeccionismo clínico, desconfianza interpersonal, conciencia interoceptiva y miedo a la madurez. La versión EDI-2 incorporó además tres escalas provisionales: ascetismo, regulación de impulsos e inseguridad social (Garner, 1991).

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS (11 SUBESCALAS · 91 ÍTEMS)

Escala / Factor	Nº Ítems	Significado Clínico y Operacional
1. Impulso a la Delgadez (DT)	7 ítems	Preocupación extrema por el peso, dieta estricta y terror a engordar.
2. Bulimia (B)	7 ítems	Tendencia a pensamientos y actos de ingesta voraz incontrolable seguida de purgas.
3. Insatisfacción Corporal (BD)	9 ítems	Disgusto específico con caderas, muslos, nalgas y vientre.
4. Ineficacia (I)	10 ítems	Sentimientos de incapacidad, baja autoestima, descontrol e inseguridad existencial.
5. Perfeccionismo (P)	6 ítems	Exigencia personal extrema y creencia de que sólo el rendimiento perfecto es válido.
6. Desconfianza Interpersonal (ID)	7 ítems	Distanciamiento afectivo, dificultad para expresar afectos y temor a la intimidad.
7. Conciencia Interoceptiva (IA)	10 ítems	Déficit en reconocer y responder a señales biológicas y emocionales.
8. Miedo a la Madurez (MF)	8 ítems	Anhelos de permanecer en la infancia para evadir exigencias de la vida adulta.
9. Ascetismo (AS - EDI-2)	8 ítems	Autocontrol rígido, renuncia intencional a placeres y disciplina física extrema.
10. Regulación Impulsos (IR - EDI-2)	11 ítems	Hostilidad, descontrol conductual, impulsividad e inestabilidad afectiva.
11. Inseguridad Social (SI - EDI-2)	8 ítems	Incomodidad, aislamiento y sensación de exclusión en contextos sociales.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMACIÓN Y REGLAS DE CORRECCIÓN · EDI-2

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATINOAMÉRICA

Consistencia Interna	Alfa de Cronbach de 0.82 a 0.93 en muestras clínicas españolas de Anorexia y Bulimia (Guimerá & Torrubia, 1987; TEA Ediciones). En población no clínica los alfas oscilan entre 0.68 y 0.90.
Validez Discriminante	Diferenciación altamente significativa ($p < 0.001$) entre pacientes con TCA y controles sanos. Discrimina con agudeza entre Anorexia Restrictiva, Anorexia Purgativa y Bulimia Nerviosa.
Validez Concurrente	Correlación elevada con el EAT-40 ($r = 0.79$), BITE ($r = 0.83$ en escala Bulimia) y BDI-II ($r = 0.68$ en escala Ineficacia).
Sensibilidad Terapéutica	Excelente sensibilidad al cambio longitudinal en respuesta a intervenciones psicoterapéuticas especializadas y programas de renutrición.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

- Sistema de Puntuación Clínico Asimétrico (0 a 3):** Cada reactivo tiene 6 opciones de respuesta (Nunca, Raras veces, A veces, A menudo, Casi siempre, Siempre).
 - Para ítems con formulación directa: Siempre = 3 puntos, Casi siempre = 2 puntos, A menudo = 1 punto; A veces, Raras veces y Nunca = 0 puntos.
 - Para ítems redactados en sentido inverso: Nunca = 3 puntos, Raras veces = 2 puntos, A veces = 1 punto; A menudo, Casi siempre y Siempre = 0 puntos.
- Cálculo por Escalas:** Se suman los valores de los ítems pertenecientes a cada subescala de forma separada.
- No se calcula una puntuación total única:** El EDI-2 es estrictamente un instrumento de perfil factorial dimensional.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Subescala Clave	Media No Clínica	Media Clínica TCA	Punto de Alarma Clínica
Impulso a la Delgadez	2.3 +- 3.5	14.8 +- 5.2	≥ 10 puntos (P85)
Bulimia	1.1 +- 2.1	10.6 +- 6.1	≥ 5 puntos (P85)
Insatisfacción Corporal	8.5 +- 6.4	18.2 +- 7.1	≥ 15 puntos (P80)
Ineficacia	2.1 +- 3.2	11.8 +- 6.4	≥ 8 puntos (P85)
Conciencia Interoceptiva	2.8 +- 3.6	12.4 +- 6.8	≥ 9 puntos (P85)

INTERPRETACIÓN DEL PERFIL PSICOPATOLÓGICO: La elevación concurrente de Ineficacia y Conciencia Interoceptiva por encima del percentil 85 es el marcador más robusto de gravedad clínica y resistencia al tratamiento. Pacientes con anorexia restrictiva típica exhiben puntuaciones muy bajas en Bulimia pero extremas en Perfeccionismo e Impulso a la Delgadez.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y DIRECTRICES · EDI-2

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

Paso 1: Análisis Gráfico del Perfil: Representar las puntuaciones típicas en el gráfico de percentiles normativos españoles según edad y sexo.

Paso 2: Diferenciación del Patrón Clínico:

- **Perfil Restrictivo Clásico:** Elevación en Impulso a la Delgadez, Perfeccionismo y Miedo a la Madurez, con Bulimia en niveles basales (0-2 puntos). Indicar protocolo cognitivo para anorexia nerviosa y reeducación ponderal.
- **Perfil Bulímico / Purgativo:** Elevación marcada en Bulimia (≥ 5) e Insatisfacción Corporal, usualmente con alta Ineficacia y desregulación emocional. Priorizar control de atracones mediante registro alimentario regular y prevención de purgas.
- **Perfil de Resistencia Psicológica:** Conciencia interoceptiva deteriorada (≥ 10): incorporar entrenamiento en alexitimia y terapia basada en mentalización.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO (VIGNETTE)

Identificación: Mujer de 21 años, estudiante de arquitectura, derivada a la Unidad de TCA ambulatoria tras pérdida del 20% del peso corporal en 6 meses (IMC actual: 16.1 kg/m²).

Perfil Psicométrico Inicial en EDI-2:

- **Impulso a la Delgadez:** 19 / 21 puntos (Percentil 99). Pánico a la grasa y conteo restrictivo implacable.
- **Bulimia:** 1 / 21 puntos (Percentil 25). Niega atracones y no realiza conductas de purga.
- **Perfeccionismo:** 17 / 18 puntos (Percentil 98). Exigencia académica obsesiva y miedo al error.
- **Ineficacia:** 15 / 30 puntos (Percentil 88). Sensación profunda de no estar a la altura de las expectativas familiares.
- **Conciencia Interoceptiva:** 14 / 30 puntos (Percentil 90). Dificultad para identificar hambre real de ansiedad o tristeza.

Abordaje Terapéutico: Se orientó la psicoterapia no sólo hacia la normalización ponderal, sino hacia la flexibilización de los esquemas de perfeccionismo desadaptativo y la validación afectiva. Se trabajó con terapia cognitivo-conductual reforzada (CBT-E de Fairburn). Tras 20 semanas, con IMC normalizado a 19.4 kg/m², las escalas de Impulso a la Delgadez e Ineficacia se redujeron al percentil 50.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALERTAS CLÍNICAS DE SEGURIDAD

- Elevación simultánea en Bulimia e Ineficacia ($> P90$) correlaciona con riesgo elevado de parasuicidio y autolesiones impulsivas.
- La presencia de purgas compensatorias frecuentes exige monitorización de iones por riesgo de paro cardíaco por hipopotasemia.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- **Trastorno Dismórfico Corporal:** Obsesión focalizada en defectos estéticos específicos (nariz, piel, asimetría facial) sin fobia general a engordar.
- **Depresión Mayor con pérdida ponderal:** Descenso de peso por hiporexia pura sin impulso activo de adelgazar.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Garner, D. M., Olmsted, M. P., & Polivy, J. (1983). Development and validation of a multidimensional Eating Disorder Inventory for anorexia nervosa and bulimia. *International Journal of Eating Disorders*, 2(2), 15–34.
- Garner, D. M. (1991). *Eating Disorder Inventory-2: Professional manual*. Psychological Assessment Resources.
- Guimerá, E., & Torrubia, R. (1987). Adaptación del Inventario de Trastornos de la Conducta Alimentaria (EDI) en una muestra española. *Revista de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Barcelona*, 14(4), 175–185.
- Fairburn, C. G. (2008). *Cognitive behavior therapy and eating disorders*. Guilford Press.